Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de São Pedro do Sul

Rua Ernesto Wagner, 233, 2º andar - Bairro: Centro - CEP: 97400000 - Fone: (55) 3029-9990 - Balcão Virtual: (55)9.9911-7542 - Email: frsaopedrovjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5001310-29.2022.8.21.0129/RS

REQUERENTE: ELIZANGELA MACIEL MARTINS
REQUERENTE: NATALIA MACIEL RODRIGUES
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL / RS

SENTENÇA

I - Relatório

NATALIA MACIEL RODRIGUES, representada por **ELIZANGELA MACIEL MARTINS,** ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL** e do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, todos qualificados.

Narrou, em síntese, que é portadora de Asma e Rinite Alérgica (CID J45, J30). Referiu que, em razão das patologias que lhe acometem, foi receitado o uso do medicamento SERETIDE 25/125mcg (4 jatos por dia) e AVAMYS (02 jatos por dia). Afirmou que os seus genitores não têm condições de adquirir o medicamento sem comprometer a subsistência. Discorreu acerca dos fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. Pugnou pela concessão da AJG. Liminarmente, requereu que a parte ré fornecesse o tratamento prescrito. Postulou a procedência da ação com a confirmação do pedido formulado liminarmente. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Recebida a inicial e deferida a AJG, foi deferida a antecipação de tutela e determinada a citação dos réus (evento 3, DESPADEC1).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (evento 9, CONT1). Preliminarmente, arguiu inépcia da petição inicial e a necessidade de chamamento da União. No mérito, falou sobre o SUS e da divisão de competências entre os entes públicos. Discorreu acerca da necessidade de cumprimento dos critérios fixados pelo STJ no Tema nº 106. Referiu que a parte autora não comprovou, através de laudo médico, a necessidade do tratamento e a ineficácia dos tratamento disponibilizados pelo SUS. Requereu a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pugnou que a parte autora seja intimada a apresentar orçamentos do(s) medicamento(s) com base na Denominação Comum Brasileira e apresente atestados médicos regulares, sob pena de suspensão do tratamento no sistema AME.

Igualmente citado, o Município de São pedro do Sul contestou a ação (evento 10, CONT2). Discorreu acerca da organização do SUS e da divisão de competência entre os entes públicos. Referiu que compete ao município apenas os tratamentos de baixa e média complexidade. Preliminarmente, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Pugnou pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, em caso de procedência, que sejam observados os protocolos do SUS e a Denominação Comum Brasileira. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 16, RÉPLICA1).

Intimadas as partes para manifestarem-se acerca da pretensão probatória (evento 18, DESPADEC1).

O Estado do Rio Grande do Sul pugnou pela intimação da parte autora para juntar atestado/laudo médico completo e juntar comprovante de rendimento dos genitores (evento 27, PET1).

Indeferidos os pedidos fe rpodução probatória formulados pelo ERGS (evento 75, DESPADEC1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 92, PARECER1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

II - Fundamentação

<u>Preliminares</u>

<u>Do chamamento da União e da ilegitimidade passiva:</u>

Aduz o requerido Estado do Rio Grande do Sul que deve ser efetuado o chamamento da União ao feito, haja vista sua competência para procedimento de alta complexidade, como o dos autos.

Por sua vez, o Município de São pedro do Sul afirmou que não possuía legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O direito à saúde, essencial à vida humana, é outorgado pela Constituição Federal de modo universal, devendo ser assegurado por qualquer dos entes federados, já que se trata de competência comum, à luz do art. 23, inc. II, da CF.

No mesmo sentido, a Lei Federal n.º 8.080/90 atribui a todos os entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que lhe prestará assistência. E, considerando que a responsabilidade é solidária, cabe à parte requerente optar por demandar contra qualquer dos entes (União, Estado ou Município), cabendo ao ente estatal, caso entenda pertinente, buscar eventual ressarcimento da União, em demanda própria ou administrativamente.

Nesse aspecto, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, *são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro* (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES CHAMAMENTO À AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E CERCEAMENTO DE DEFESA DO ESTADO. AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TANTO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUANTO O MUNICÍPIO SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE INTERNAÇÕES COMPULSÓRIAS E ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL E DROGADIÇÃO. QUANTO AO CERCEAMENTO, É DE COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO AVALIAR A NECESSIDADE E PERTINÊNCIA DAS PROVAS REQUERIDAS, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS. DO CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. EXISTINDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, CONVÉM AO CREDOR A FACULDADE DE ESCOLHER, ENTRE OS QUAIS IRÁ SER DEMANDADO PARA ATENDER A OBRIGAÇÃO. DO MÉRITO. COMPROVADA A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO, CONSOANTE SE VERIFICOU NO DECURSO DO FEITO, NÃO HÁ COMO ISENTAR OS ENTES PÚBLICOS DE PROVER TAL MEDIDA, MESMO QUE EM CLINICA PARTICULAR, HAJA VISTA QUE O DIREITO À SAÚDE PROVÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIREITO À VIDA GARANTIDOS PELA CARTA MAGNA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 50001909420198210083, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 25-08-2021)*

Ademais, tratando-se de demanda cujo valor da causa é inferior a 210 salários-mínimos, o processamento da ação é de competência da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1234 do STF.

Logo, rejeito as preliminares.

<u>Da inépcia da inicial (pedido genérico):</u>

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL suscitou em sede de contestação (evento 10, CONT2) a inépcia da inicial em razão de pedido incerto e genérico.

Do exame da inicial, verifica-se que que há pedido genérico e indeterminado, já que extensível a novos medicamentos e tratamentos - o que, posteriormente ao julgamento do processo, poderia oportunizar obrigação infinita aos demandados.

Logo, acolho parcialmente a preliminar, para condicionar o julgamento meritório da demanda ao tratamento indicado pela parte postulante na petição inicial, qual seja, tratamento médico com os fármacos SERETIDE 25/125mcg (4 jatos por dia) e AVAMYS (02 jatos por dia).

<u>Da Denominação Comum Brasileira:</u>

De início, imperioso destacar que o nosso Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO **RITALINA** LA (CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG). DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de **Ritalina** LA 20 mg (Cloridrato de Metilfenidato 20 mg) a M. A. A. B., representado por sua genitora, com base na necessidade do medicamento para **tratamento** de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A sentença condicionou a entrega do medicamento à atualização semestral do receituário médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fornecimento do medicamento postulado com base na Denominação Comum Brasileira, em vez do nome comercial, considerando os princípios da impessoalidade e as legislações pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR: Possibilidade de fornecimento do medicamento/insumo na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei Federal nº 9.787/99), desde que seja mantida a dosagem prescrita e contenha as substâncias que compõem o seu princípio ativo. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido para permitir que o fornecimento do medicamento seja realizado de acordo com a Denominação Comum Brasileira, desde que mantida a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.787/99, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 50019837920208210068, Relator: Denise Oliveira Cezar, julgado em 28-06-2023. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50029124420248210013, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-03-2025)*

No mais, considerando que o feito transcorreu regularmente, não havendo nulidades a serem sanadas ou preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Do mérito

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por NATALIA MACIEL RODRIGUES contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**,** ante a necessidade do autor de fazer uso dos medicamentos SERETIDE 25/125mcg (4 jatos por dia) e AVAMYS (02 jatos por dia), em razão de ser ser portadora de Asma e Rinite Alérgica (CID J45, J30).

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde e o dever do Estado. A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS – Sistema Único de Saúde - e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, é claro quanto a esse dever do Estado:

> *Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.*
>
> *Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (...) § 2 º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao **tratamento**, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.*

Nesse passo, cumpre destacar que para atender a esse relevante direito fundamental, foi estabelecida a responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos dos artigos 23, II, e 196, ambos da Constituição Federal, conforme decidido no Tema 793, nos autos do RE nº 855.178, com reconhecimento da repercussão geral:

> *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".*

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em observância ao tema, reafirmou o entendimento no sentido de que não é vedado ao cidadão que exija o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes públicos, visto que solidariamente responsáveis.

Neste sentido:

> *DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO CIRÚRGICO. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E COM DIAGNÓSTICO DE SEQUELAS DE LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DECORRENTE DE ACIDENTE DE MOTO. DEVER DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS ENTES PÚBLICOS. REGRA DO ART. 196 DA CF-88. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MATÉRIA SOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 793). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DE CADA PACIENTE. RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE). POSSIBILIDADE. TEMA Nº 06 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSIDERADO E APLICADO. IMPUGNAÇÃO DOS CUSTOS DO TRATAMENTO E COBRANÇA DE VALORES QUE EXTRAPOLA O OBJETO DA LIDE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, diante da solidariedade existente entre os entes públicos no atendimento à saúde pública, tal como prevista no artigo 196 e seguintes da CF-88. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178 (Tema nº 793) com solução de mérito que desautoriza a tese do apelante. 2. Mérito: O autor, menor púbere, representado por sua genitora, carente de recursos financeiros, apresenta diagnóstico de sequelas de lesões no membro inferior esquerdo decorrente de acidente de moto e necessita ser avaliada por médico traumatologista e ser submetido a procedimentos cirúrgicos. Dever de custeio pelos entes públicos, uma vez que implementados os requisitos postos na legislação de regência. Superdireito à saúde que deve prevalecer sobre os princípios orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelo ente público. Ausência de afronta aos princípios da independência e autonomia dos Poderes. Responsabilidade solidária de todos os entes gestores do SUS em nível nacional, regional e municipal. Fontes de custeio e questões orçamentárias e fiscais que não devem embaraçar o direito à vida e saúde. Tema nº 06 da repercussão geral do STF aplicado. 3. A prova dos autos amparada em laudos médicos e relatórios de atendimento de emergência hospitalar são suficientes para demonstrar a necessidade de tratamento do apelado. 4. Impugnação dos custos de tratamento pelo Estado e pretensão de cobrança de valores que entende terem sido pagos a maior que refogem ao objeto da presente lide. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70083532762, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 12-11-2020) (destaquei)*

Outrossim, o egrégio TJRS firmou o entendimento de que eventual pleito de ressarcimento formulado pelo ente público obrigado deve ser realizado na esfera administrativa ou por ação própria:

> *AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. TEMAS 793 E 1234 DO STF. JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DO STF. MÉRITO. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA NESTA INSTÂNCIA. 1. O entendimento desta Corte era no sentido de que todas as demandas em que se buscasse o fornecimento de **tratamento**, procedimento, material ou medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS se fazia necessária a inclusão da **União** no polo passivo. Contudo, o Ministro Gilmar Mendes, ao deferir parcialmente tutela provisória nos autos do RE 1366243 (Tema 1234), determinou que as demandas com sentença prolatada até a data da decisão (17/04/2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. 1.1. Conquanto a tese firmada quando do julgamento do RE 657.718, Tema 500/STF, relativo à possibilidade ou não de o Estado fornecer medicamentos não registrados na ANVISA, preveja que "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União", foi consignada exceção quanto aos produtos à base de canabidiol, isso em razão da existência de regulação permitindo a importação, a teor da Resolução 130/2016. Logo, considerando que no caso concreto a sentença foi prolatada antes de 17/04/2023, cumpre realizar análise do mérito. **2. O e. STF, ao julgar o Tema 793, reafirmou a competência solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos. Não há, pois, no caso em apreço, falar em ilegitimidade passiva da parte ré, em face do dever***

solidário de prestação, constitucionalmente estabelecido. Isso porque, ao mesmo tempo que otimizou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, a Suprema Corte também reforçou a solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde. Ademais, o ressarcimento entre os entes federados reclama demanda própria. Jurisprudência desta Corte. *3. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 106, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso específico, a parte requerente comprovou o preenchimento de tais requisitos. 4. Sentença de procedência do pedido mantida nesta instância. Honorários advocatícios majorados conforme disposto no §11 do artigo 85 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50014686820208210060, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 08-11-2023) (destaquei)*

O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

A prestação jurisdicional, todavia, não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

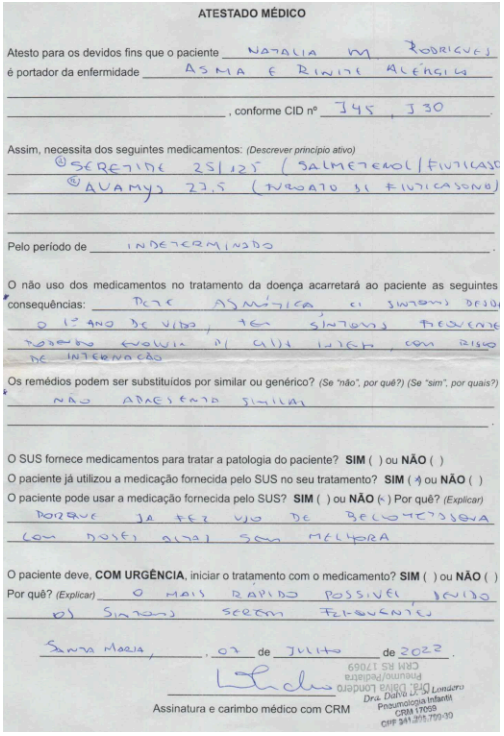
Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, o STJ fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o **tratamento** da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No presente feito, conforme laudo médico juntado (evento 1, LAUDO7, fl. 06), a parte autora é portadora de Asma e Rinite Alérgica (CID J45, J30) e necessita dos fármacos postulados:



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente NATALIA M. RODRIGUES
é portador da enfermidade ASMA E RINITE ALÉRGICA
, conforme CID nº J45, J30.

Assim, necessita dos seguintes medicamentos: *(Descrever princípio ativo)*
① SERETIDE 25/125 (SALMETEROL/FLUTICASONA)
② AVAMYS 27,5 (FUROATO DE FLUTICASONA)

Pelo período de INDETERMINADO.

O não uso dos medicamentos no tratamento da doença acarretará ao paciente as seguintes consequências: DEVE ASMÁTICA CI SINTOMAS DESDE O 1º ANO DE VIDA, TEM SINTOMAS FREQUENTE PODERÁ EVOLUIR P/ CRISE GRAVE, COM RISCO DE INTERNAÇÃO

Os remédios podem ser substituídos por similar ou genérico? *(Se "não", por quê?) (Se "sim", por quais?)*
NÃO APRESENTA SIMILAR.

O SUS fornece medicamentos para tratar a patologia do paciente? **SIM** ( ) ou **NÃO** ( )
O paciente já utilizou a medicação fornecida pelo SUS no seu tratamento? **SIM** (✓) ou **NÃO** ( )
O paciente pode usar a medicação fornecida pelo SUS? **SIM** ( ) ou **NÃO** (✓) Por quê? *(Explicar)*
PORQUE JÁ FEZ USO DE BECLOMETASONA COM DOSES ALTAS SEM MELHORA

O paciente deve, **COM URGÊNCIA**, iniciar o tratamento com o medicamento? **SIM** ( ) ou **NÃO** ( )
Por quê? *(Explicar)* O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL DEVIDO OS SINTOMAS SEREM FREQUENTES

Santa Maria, 07 de Julho de 2023.

Assinatura e carimbo médico com CRM

Dra. Dulce L. S. Londero
Pneumologia Infantil
CRM 17059
CPF 341.315.770-20

Pneumo/Pediatra
CRM RS 17059
Dra. Dulce Lóvia Londero

Ademais, o atestado médico colacionado indica a necessidade de uso da medicação (evento 1, OUT8, fl. 02), sob pena de evolução quanto a gravidade da doença, com risco de internação.

Além disso, o atestado é claro ao referir que não são disponibilizadas alternativas ao medicamento pelo SUS.

Por sua vez foi comprovada a hipossuficiência dos genitores da infante (evento 1, DOC4), o que soma-se ao fato de que este é representado pela Defensoria Pública, o que corrobora a hipossuficiência alegada e a impossibilidade de arcar com os custos de aquisição do medicamento sem prejuízo de seu sustento.

Nesta senda, em consulta ao site da ANVISA, verifica-se a existência de registro dos fármacos junto à autarquia federal.

Observa-se, portanto, que, na hipótese, que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n° 106 – STJ), quais sejam: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro na Anvisa do medicamento.

Comprovada a necessidade e urgência na utilização do insumo, imperioso responsabilizar os entes públicos demandados pelo seu fornecimento

Em relação ao ressarcimento por parte da União, caso entendam pertinente, os requeridos poderão solicitar por via administrativa ou através de ação judicial própria.

Logo, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

III - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **ELIZANGELA MACIEL MARTINS e NATALIA MACIEL RODRIGUES** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL**, para fins de **CONFIRMAR a antecipação de tutela deferida (evento 3, DESPADEC1)** e **CONDENAR** os réus ao fornecimento ou custeio dos medicamentos **XINAFOATO DE SALMETEROL/PROPIONATO DE FLUTICASONA (SERETIDE)** e **FUROATO DE FLUTICASONA (AVAMYS).**

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da FADEP, os quais fixo em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Consigno que não há falar em confusão na condenação do ERGS ao pagamento de honorários em favor da FADEP, consoante Tema 1002 do STF e jurisprudência do TJRS[1].

Isento as partes do pagamento de custas, visto se tratar de feito referente à Infância e Juventude, nos termos do art. 141, § 2º, do ECA.

Dispensada a remessa necessária, por força do art. 496, §3º, inc. III, do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Agendada intimação eletrônica das partes.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **WALKYRIA MARIA ALVARES DOS PRAZERES C DE S C, Juíza de Direito**, em 23/04/2025, às 15:31:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10080761260v2** e o código CRC **aaa7ee67**.

---

1. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA 793/STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS À FADEP. POSSIBILIDADE. 1. O Tema 793/STF reafirmou a jurisprudência acerca da solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde, tema que encontra, inclusive, respaldo constitucional (art. 23, II, da CF). 2. Honorários advocatícios à FADEP. Possibilidade. Aplicação do Tema 1002 do STF: pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. PROVIDO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DESPROVIDO RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.(Apelação Cível, Nº 50015057420238210033, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 28-03-2025) ↩